

药物相互作用在评价合理用药中的意义

河南平顶山市第二人民医院(467000) 杨花平

【关键词】药物相互作用 合理用药

目前,临床用药几乎不存在一次只用一种药物的情况,合并用药的核心是增强药效,减少用量及不良反应,降低副作用,随着多种药物合用病例数的增加,药物不良反应率也在迅速上升,其中药物相互作用是药物不良反应和毒性反应的重要原因。因此,研究药物的相互作用对评价合理用药更有指导意义。

1. 确定有益的相互作用

临床上将药物联合使用后,获得药效增强或毒副作用降低的效果,即为有益的相互作用。当单独使用一种药物,即使浓度达到最大,只俩也难以奏效时,则必须考虑合并用药,如器官移植后合用多种免疫抑制剂、对恶性肿瘤的联合化疗、对某些感染性疾病合用多种抗生素等。在这众多纷纭的联合用药中,应确定有益的相互作用。

例如在诱导麻醉时,阿片类镇痛药能增强苯二氮类的镇静作用。阿片类药物和苯二氮类药物的协同镇静作用对诱导麻醉是有益的相互作用。阿托品与碘解磷定合用,碘解磷定可复活胆碱酯酶,减少乙酰胆碱的蓄积,阿托品对抗乙酰胆碱,两药合用可起协同作用^[1]。

2. 注意有害的相互作用

当药物联合使用后,使得药效减低或毒副作用增强的效果,即为有害的相互作用。临床对能够产生药物配伍禁忌的联合用药已经引起足够的重视,有些药物的相互作用可导致出血、低血糖休克、惊厥及高血压危象等。如双香豆素与吡咪美辛合用,使双香豆素血浓度增加,增强其抗凝作用,易引起出血;吩噻嗪类药物与利尿药合用可导致低血压或休克等。

避免出现有害相互作用的策略是:尽量不联合使用同类药物,规定长期药物治疗过程,必须先从小剂量开始,逐渐增加剂量直至出现满意疗效为止。

3. 有的放矢的联合用药

医药工作者不可能对任何两种药物的相互作用均了解清楚,因此,在临床用药时应有的放矢,将重点放在最重要的相互作用上,尤其是易产生严重不良反应的药物和患者的病情及年龄。

3.1 有严重不良反应的药物 能产生严重不良反应如心跳骤停或心律失常、呼吸中枢抑制或呼吸麻醉引起的呼吸衰竭、低血压休克、高血压危象、低血糖昏迷、惊厥、出血、肝肾骨髓等器官实质性损害等的药物,也属于危险性较大的药物。例如,作用于重要生命过程的华法林、吗啡、氯丙嗪等;量-效曲线陡直的维拉帕米、左旋多巴、氯磺丙脲等;有浓度依赖性产生毒性的地高辛、钾盐、氨基糖苷类抗生素、甲氧蝶呤等^[2];作用减弱导致病情加重

的奎尼丁、泼尼松龙、丙戊酸钠、卡马西平等;有饱和性肝代谢的苯妥英钠、乙醇、茶碱等。

3.2 患者的病情和年龄也是发生严重不良相互作用的重要因素。痴呆、严重贫血、心衰、肝性脑病等患者抗病能力较差;严重糖尿病、发作性心律不齐、难治性癫痫等能因药物不良的相互作用而使病情加重;肝、肾或肺的病变和病毒性肝炎等亦可增加药物不良相互作用的严重性。

一般老年人易使用多种药物,而且自身维持内环境稳定的代偿能力下降,有多种病变,较易产生不良的药物相互作用。尤其对作用于心血管和中枢神经系统药物的不良作用较为敏感,而发生危险。

4. 加强用药指导

为了使联合用药所产生的相互作用真正达到临床所需的增强药效或降低毒副作用的目的,对于合并用药必须加强指导,尤其是药物相互作用在体内反应隐蔽,易与疾病本身症状混淆,不易发现,变异性大,难以预测的更应引起重视,以避免药物不良相互作用的发生。

4.1 加强医生之间,医生与病人之间的相互沟通:即与同一患者的其他科室的医生共同协商用药,并详细了解患者近期用药情况,可避免有害的相互作用。

4.2 对于易产生严重不良反应的药物即治疗指数小,量-效曲线陡直,能诱导自身代谢或竞争代谢通路,影响重要生理机能,应详细地指导用药^[3]。

4.3 对于长期用药或使用多种药物的患者、老年患者、肝肾功能减退而使药物清除率低的患者,应谨慎选用药物和剂量。

4.4 指导用药期间饮食生活习惯:如快速乙醇的摄入能增强中枢神经系统某些神经元上的 GABA_A 受体的作用,说明乙醇有镇静作用,可加强阿片类药物和苯二氮类药物的作用。吸烟并使用可卡因能产生不利于健康的协同作用,降低心肌供氧和增加心肌耗氧。

一般而言,合理的用药原则为:能用一种药物,就不要使用两种药物;联合用药选用有益相互作用的药物,避免使用有害相互作用的药物。

参考文献

1. 陈新谦. 等. 新编药理学. 第 15 版, 北京: 人民卫生出版社; 2003, 168-169
2. 李焕德. 等. 临床药理学. 北京: 人民卫生出版社; 2003, 303-304
3. 吴笑春. 药源性疾病诊治手册. 北京: 人民军医出版社; 2005, 236